

Abdome agudo - raciocínio e prioridades

Abdome agudo exige decidir rápido: há peritonite ou instabilidade que imponha cirurgia? TC ajuda no estável; no instável com abdome cirúrgico, vá ao centro cirúrgico.

Exame dirigido

Dica - Exame dirigido

Localização da dor, irradiação, febre, parada seletiva de eliminações, hérnia encarcerada e toque retal fazem parte do exame mínimo de prova.

Separe quem opera agora, quem investiga com imagem e quem tem causa clínica (cetoacidose, pneumonia basal, IAM).



Checklist da porta

- ABC, acesso, analgésico (não 'mascara' diagnóstico moderno — alivie dor)
- Labs: hemograma, PCR, lactato, função renal, ;"Ö,4r VÒ Đulher fértil
- Imagem: Rx se perfuração/obstrução; TC contrastada no estável duvidoso
- Cirurgia cedo se defesa, ar livre, isquemia ou hérnia estrangulada

Dor por quadrante (atalhos)

Local | Pensar em

QSD | Colecistite, úlcera, pneumonia

QSE | Pancreatite, úlcera, baço

FIE | Diverticulite

FID | Apendicite, anexial, ileíte

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Toda mulher em idade fértil com dor abdominal: ;"Ö,4r çFW2 FR -Ö vVÒ -öæ—| çFRö6— urgia eletiva.
Idoso: apendicite e isquemia apresentam-se atípicas — limiar baixo para TC.